

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5102744-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANA CRISTINA DA SILVA VALENTE RAMOS

RECORRIDO: GABRIEL DA SILVA VALENTE RAMOS

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTE COM ENCEFALOPATIA CRÔNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5102744-76.2024.4.02.5101

510015445552 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5102744-76.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANA CRISTINA DA SILVA VALENTE RAMOS

RECORRIDO: GABRIEL DA SILVA VALENTE RAMOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela União em face do deferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 5ª VF do Rio de Janeiro [evento 29, DESPADEC1], com o seguinte teor:

*"(...) **DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar aos réus que, dentro de suas esferas de competências administrativas, providenciem para a parte autora **os insumos: Ventilador para ventilação invasiva e não invasiva com umidificador para base do ventilador, Oxímetro de pulso de mesa ou portátil com monitorização contínua, Concentrador elétrico de oxigênio com capacidade de 5L/minuto, Cilindro de oxigênio com capacidade de 4m³ acompanhado de copo umidificador, Cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ acompanhado de copo umidificador, Frasco de aspiração para conexão em cilindro de oxigênio, Máscara de traqueostomia com tubo extensor, Sistema de alimentação de energia elétrica secundária nobreak, Nebulizador elétrico tipo compressor, Aspirador elétrico de secreções, Ambu adulto completo com máscara e reservatório, Cânula plástica de traqueostomia 6,5 com balão, Fixador de cânula de traqueostomia, Curativo absorvente para traqueostomia, Sonda de aspiração traqueal número 8, Borracha/tubo extensor para aspiração, Seringa de 3mL, Seringa de 5L, Seringa de 10mL, Seringa de 20mL e Seringa de 60mL**, conforme laudo firmado pelo Dr. Gabriel Deveza Gomes (CRM RJ 52104414-1), no Evento 1 Anexo 2 Fls 11/14, confirmado pelo NAT, consoante o parecer juntado no Evento 7, a partir da intimação desta, à vista do real estado de saúde da requerente, sem olvidar da necessidade de eficiência do tratamento e seus custos, sob responsabilidade penal, civil e administrativa dos responsáveis, na forma da lei".*

Em apertada síntese, a União pretende a suspensão da tutela provisória de urgência, ao argumento de carência do requisito "probabilidade do direito". Pontua que a CONITEC recomendou a incorporação da oxigenoterapia domiciliar exclusivamente para o tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Ainda, suscita a irreversibilidade da medida, a ausência de perigo de dano ao resultado útil do processo. Na hipótese de manutenção da decisão, pretende ver direcionado o cumprimento ao Município.

Deferido parcialmente o efeito suspensivo em decisão monocrática, para determinar o direcionamento preferencial da obrigação ao Município do Rio de Janeiro, na forma do Tema 793 do STF, por ser o ente gestor do PADI - Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso, sem prejuízo do cumprimento subsidiário pelos demais entes federativos [evento 3, DESPADEC1].

Sem contrarrazões pelas recorridas, em que pese devidamente intimadas.

Peticionamento do Município do Rio de Janeiro comunicando cumprimento da tutela [evento 12, PET1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que concedeu parcialmente o efeito suspensivo, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Na espécie, o demandante, ora recorrido, é menor diagnosticado com encefalopatia crônica não progressiva (CID 10: P91.6), hidrocefalia (CID 10: Q03.9), derivação ventrículo-peritoneal (CID 10: Z98.2), epilepsia (CID 10: G40.9), doença pulmonar crônica com dependência de ventilação mecânica contínua (CID 10: Z99.1) e oxigenoterapia (CID 10: Z99.8), hipertensão arterial sistêmica (CID 10: I10), prematuridade (CID 10: P07.3), traqueostomia (CID 10:Z93) e gastrostomia (CID 10:Z93.1) [evento 1, ANEXO2, fl. 11, autos de origem].

Narra o laudo firmado pelo médico assistente que o recorrido encontra-se internado, mas "(...) tem condições de alta hospitalar para acompanhamento pelo Programa de Assistência Domiciliar Interdisciplinar do Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz (PADI/IFF), sendo dependente de ventilação mecânica em BIPAP 12x6 noturna e oxigenoterapia diurna via traqueostomia e dieta exclusivamente via gastromia, além de receber diversas medicações (...) [evento 1, ANEXO2, fl. 11, último parágrafo, autos de origem].

Nesta guisa, pretendeu o demandante a concessão de tutela de urgência para concessão dos insumos mencionados na decisão impugnada, conforme transcrição supra.

A pretensão foi confirmada pelo parecer exarado pelo NAT-Jus nos autos de origem [evento 7, PARECER1], onde há confirmação de que os insumos e equipamentos estão indicados para o quadro clínico do recorrido, mas não são fornecidos pelo SUS e não existem alternativas terapêuticas. Ainda assim, a alta hospitalar seria possível, se o paciente recebe em comodato (empréstimo) os aparelhos necessários, pelo PADI - Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso, levado a cabo pelo Município do Rio de Janeiro:

*"Assim, informa-se que ventilador para ventilação invasiva e não invasiva com umidificador, oxímetro de pulso (mesa ou portátil), concentrador elétrico de oxigênio, cilindros de oxigênio (4m3 e 1m3) com copo umidificador, frasco de aspiração, máscara de traqueostomia com tubo extensor, nobreak, nebulizador elétrico (tipo compressor), aspirador elétrico de secreções, ambu (adulto) com máscara e reservatório, cânula plástica de traqueostomia (6,5 com balão), fixador de cânula de traqueostomia, curativo absorvente para traqueostomia, sonda de aspiração traqueal (8Fr), borracha/tubo extensor para aspiração, seringas (3ml, 5ml, 10ml, 20ml e 60ml) **estão indicados ao manejo da condição clínica do Autor** - Encefalopatia Crônica não Progressiva, hidrocefalia, Derivação Ventrículo-Peritoneal, Doença Pulmonar crônica com dependência de oxigenoterapia e ventilação mecânica contínua através de traqueostomia (Evento 1, ANEXO2, Páginas 11 e 12).*

*Quanto à disponibilização dos pleitos no âmbito do SUS, informa-se que ventilador para ventilação invasiva e não invasiva com umidificador, oxímetro de pulso (mesa ou portátil), concentrador elétrico de oxigênio, cilindros de oxigênio (4m3 e 1m3) com copo umidificador, frasco de aspiração, máscara de traqueostomia com tubo extensor, nobreak, nebulizador elétrico (tipo compressor), aspirador elétrico de secreções, ambu (adulto) com máscara e reservatório, cânula plástica de traqueostomia (6,5 com balão), fixador de cânula de traqueostomia, curativo absorvente para traqueostomia, sonda de aspiração traqueal (8Fr), borracha/tubo extensor para aspiração, seringas (3ml, 5ml, 10ml, 20ml e 60ml) **não se encontram disponibilizados no SUS**, pela via administrativa, no âmbito do município e do estado do Rio de Janeiro, bem como não foram identificados outros insumos que possam configurar alternativa.*

No entanto, acrescenta-se que em documento médico do Instituto Fernandes Figueira (Evento 1, ANEXO2, Página 12), unidade na qual o Autor recebe assistência, foi informado que o Autor "poderá ter alta recebendo equipamentos, medicamentos e insumos por empréstimo pelo PADI, em regime domiciliar".

A Prefeitura do Rio implantou, em agosto de 2010, o Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI), que oferece assistência em casa, prioritariamente, a pessoas com 60 anos ou mais de idade, mas sem restrição de faixa etária. O serviço é prestado aos portadores de doenças que necessitem de cuidados contínuos que possam ser feitos na residência. O PADI cuida de pessoas com doenças crônicas agudizadas, portadores de incapacidade funcional provisória ou permanente, pacientes oriundos de internações prolongadas e/ou recorrentes, com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção, pacientes em cuidados paliativos e outros agravos passíveis de recuperação funcional³. (grifo nosso)

Ao fim, conclui o parecer que a unidade hospitalar onde se encontra o recorrido deverá solicitar sua inclusão no PADI, a fim de que tenha acesso aos equipamentos pretendidos, o que foi encampado pela decisão recorrida, ao determinar às rés que providenciem o acesso aos insumos.

A seu turno, a recorrente entende que falta à causa a probabilidade do direito, porquanto a oxigenoterapia domiciliar seria destinada exclusivamente para o tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

A alegação não merece ser acolhida, porquanto há documentação técnica robusta confirmando a indicação da oxigenoterapia ao quadro clínico do demandante, ora recorrido. Neste sentido não apenas o laudo do médico assistente, mas o parecer exarado pelo NAT-Jus, conforme acima destacado.

Não suficiente, pontua a suposta irreversibilidade da medida e a ausência de periculum in mora. Novamente, não merecem acolhida as teses, porquanto a medida é absolutamente reversível, especialmente se o fornecimento se der na forma de comodato através do PADI. Já o perigo de dano se verifica no fato de que tais insumos são imprescindíveis à manutenção da vida do recorrido no ambiente domiciliar.

Em caráter subsidiário, a recorrente pontua a necessidade de redirecionamento da obrigação em face do Município, pois o PADI é programa promovido pelo ente municipal. A pretensão encontra eco na documentação anexa aos autos de origem, especialmente no parecer exarado pelo NAT-Jus, segundo o qual "A Prefeitura do Rio implantou, em agosto de 2010, o Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI), que oferece assistência em casa, prioritariamente, a pessoas com 60 anos ou mais de idade, mas sem restrição de faixa etária".

Nesta linha de intelecção, vale registrar que o STF, em sede de repercussão geral, confirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos em temas pertinentes à área da saúde, conferindo o magistrado o poder-dever de direcionar o cumprimento da obrigação, sem prejuízo do ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tema 793 - STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Na espécie, consoante exaustivamente pontuado, o fornecimento dos equipamentos pode ocorrer através da inclusão do recorrido ao PADI, programa levado a cabo pelo Município do Rio de Janeiro. Por isso, entendo pertinente o direcionamento da obrigação preferencialmente ao ente municipal, sem prejuízo do cumprimento subsidiário pelas demais entidades federativas.

*Pelo exposto, **DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL, tão somente para determinar o direcionamento preferencial da obrigação ao Município do Rio de Janeiro, na forma do Tema 793 do STF, por ser o ente gestor do PADI - Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso, sem prejuízo do cumprimento subsidiário pelos demais entes federativos.***

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de concessão do parcial do efeito suspensivo e, no mérito, merece parcial provimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.